

acompanhamento () consulta

NS 22231697071 | 219

ROSEMARY LOPES

IDADE: 79 PESO: 49 ALTURA: 158 PROFISSÃO: Professora - Aposent.

SINTOMAS: Dor de cabeça.

QUEIXAS: Sonolência - Acorda algumas vezes engasgado

MEDICAMENTOS: Quicor (40mg) - Nebock - Prisma - Clonazepam
Rasapina (30mg) - Virtuos (almoco)

MÉDICO: Psig. Laura Pereira - Dr. Marco Apelo.

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: 2x semana musculação

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: (18) JANTAR: -

HORA QUE DORME: 23:30 HORA QUE ACORDA: 8h

COCHILHO (X) SIM () NÃO 30' DORME ACOMPANHADO () SIM ☒ NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA ☒ NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: sim BANHEIRO: 1 (raro)

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: III IAH: 25,2 SPO2: 79%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: gastrite - gases no estômago / Rinite

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS

13/06 - Avaliação

20/06 P= 6 cm H₂O Relata melhora da
24 IAH= 1,3 e/ev obstrução nasal e dor
M. de uso: 5h 10' de cabeça. sua
Oriento p/ que esqueça o CPAP.

04/07 P= 6 cm H₂O
24 IAH= 2,2 e/h Oriento colocação
m de uso: 4h 9' da máscara
fuga: 53,6 l/m
Natasha

26/07 P= 6 cm H₂O
24 IAH= 0,6 e/h Conversemos por telefone
m de uso: 5h 44' p/ relata melhora
fuga: 22,4 l/m no sono e adaptação
ao equipamento.
diminuição no uso dos
medicamentos psicotrópicos

Natasha

02/08 P= 6 cm H₂O
24 IAH= 0,5 e/ev
M. de uso: 6h 8'
fuga = 27,4 e/ev

Sua cláudia

05/09/24 P= 6cmH₂O
IAH= 0,8 e/h
m. de uso: 6h40'

TROCOU O CPAP, comprou
novo

29/09/24 P= 6cmH₂O

22/11/24 P= 6cmH₂O
IAH= 2,9 e/h
m. uso: 6h30 min
fuga: 34 l/min

sendo apnéia noturna

leito P: 5,8 cmH₂O
agendo retorno 7 dias

29/11/24 P= 5,8 cmH₂O
IAH= 0,3 e/h
m. uso: 6h47 min
fuga: 33 l/min

refere melhora apnéia noturna

31/01/25 P= 5,8 cmH₂O
IAH= 0,8 e/h
m. uso: 6 horas
fuga: 20 l/min

Bem adaptada

* troca de filtro *

04/04/25 P= 5,8 cmH₂O
IAH= 0,7 e/h
m. uso: 5h30' min
fuga: 29 l/min

Bem adaptada

dorme tarde

26/06/25 P= 5,8 cmH₂O
IAH= 0,8 e/h
m. de uso: 5h37'
fuga: 17,7 l/min

* troca filtro *

Natasha

Laísa Pereira Oliveira

MÉDICA PSIQUIATRA: CRM-SP192990 RQE91047

Rosemary Lopes

CPF: 184.409.088-49

Data e hora: 06/06/2024 - 10:22:59 (G)

Encaminhamento

Para a Medicina do Sono

Encaminho paciente para adaptação ao aparelho de CPAP.

Indicação: apneia do sono moderada, já com teste de CPAP

CID

G473 - Apnéia de sono

Laísa Pereira Oliveira
Médica Psiquiatra
CRMSP 192990 / RQE 91047



MEMED - Acesso à sua receita digital via QR Code
Endereço: Rua Santa Elza, 261

Laísa Pereira Oliveira - CRM 192990 SP

Token (Farmácia): 37uEhx - Código de desbloqueio (Paciente): 2423

Rua Santa Elza, 261, Vila Adyana, São José dos Campos- SP
TEL: (12) 99633-7305 (horário: das 9h as 20h de segunda a sexta-feira)

03/08
12120

Nome: ROSEMARY LOPES
Data de Nascimento: 21-2-1945
IMC: 19,63
Sexo: Feminino
Data do exame: 21-05-2024

Peso: 49 kg
Altura: 1,58 m
Médico: DRA. LAISA PEREIRA OLIVEIRA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 21-05-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 479,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 96,0 e 296,5 minutos. O tempo total de sono foi de 208,0 min, eficiência de 43,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,4%; estágio N2: 62,7%; estágio N3: 19,5%; sono REM: 15,4%. O índice de despertares foi de 1,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 1,4/hora, sendo 1 obstrutiva, 0 mistas e 0 centrais e 4 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e a mínima de 89%, permanecendo 0,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 58 - 63 bpm e NREM de 58 - 71 bpm.

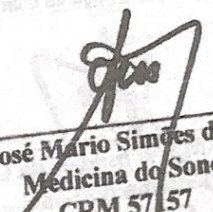
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (9), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latências para o sono prolongadas;
4. número de despertares breves normal;
5. registro de ronco durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 6,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: ROSEMARY LOPES

Data de Nascimento: 21-2-1945

IMC: 19,63

Sexo: Feminino

Data do exame: 19-09-2023

Peso: 49 kg

Altura: 1,58 m

Médico: DRA. LAISA PEREIRA OLIVEIRA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 19-09-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 524,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 155,5 e 126,5 minutos. O tempo total de sono foi de 288,0 min, eficiência de 55,0% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,0%; estágio N2: 50,3%; estágio N3: 27,3%; sono REM: 21,4%. O índice de despertares foi de 8,6/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 25,2/hora, sendo 54 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 15 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e a mínima de 79%, permanecendo 5,5% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 57 - 70 bpm e NREM de 59 - 72 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (10), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N3 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 25,2/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=79%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. número de despertares breves normal;
7. registro de ronco durante o sono.

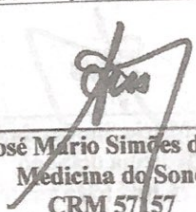
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57